

Guide d'administration

Protocole *Géfitinib*

Rédaction : novembre 2017

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexe : score de Child-Pugh](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique en monothérapie chez les patients porteurs de la mutation de l'EGFR¹.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0 à 2

- › Évaluation de l'INESSS (novembre 2011) :
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/ProjetPilote_Cancer/Document_synthese_final_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (octobre 2017) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx>
(médicament d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

Le géfitinib s'administre sans arrêt par voie orale une fois par jour avec ou sans nourriture.

Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou apparition de toxicité inacceptable.

Cycle de 28 jours.

2.2. Schéma d'administration¹

Médicament	Dose	Description
Géfitinib	250 mg 1 fois par jour en continu	› Par voie orale. › Comprimés de 250 mg. › Ne pas couper, écraser ou mâcher. › Avec ou sans nourriture.
› <i>Poursuivre jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable</i>		
Considérations spéciales ¹ :		
› Il est possible de dissoudre les comprimés de géfitinib (sans les écraser) dans un demi-verre d'eau. Il est alors important de brasser le liquide jusqu'à ce que les comprimés soient complètement dissous (environ 10 minutes) et de le boire sans tarder. Ensuite, remplir à nouveau le verre d'eau à moitié et boire immédiatement. La solution contenant les comprimés dissous peut être administrée par sonde nasogastrique. › Les comprimés de géfitinib contiennent du lactose. › En cas d'oubli d'une dose, la dose peut être prise s'il reste plus de 12 heures avant la prochaine dose.		

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation**
 - Aucune au préalable
- › **Antémétiques** : très faiblement émétisant (< 10 %)²
 - Pré-chimiothérapie : aucun antiémétique.
 - Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance des diarrhées³** :
 - Hydratation orale.
 - Pour des diarrhées légères à modérées (moins de 4 selles molles par jour), le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
 - En cas de diarrhées modérées à sévères (plus de 4 à 6 selles molles par jour ou diarrhée nocturne), le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux heures) peut s'avérer utile.
- › **Prévention du rash** : les méthodes prophylactiques suivantes sont essentielles dans la prise en charge des éruptions cutanées avec le géfitinib^{3,4} :
 - Crème solaire (FPS ≥ 30).
 - Crème hydratante BID sans parfum ni alcool.
 - Corticostéroïde topique (hydrocortisone 1% crème HS-BID)
 - Considérer :
 - Antibiotique oral (minocycline 100 mg BID ou 50 mg BID, doxycycline 100 mg BID pour 6 semaines)³. Peut être donné en prophylaxie dès le début du géfitinib ou en traitement lors de l'apparition du rash.
 - Antibiotique topique en traitement (clindamycine 1% crème ou lotion sans alcool BID). Privilégier voie orale en prévention.
- › **Surveillance de la mucosite³** :
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale¹

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Géfitinib	Aucun ajustement requis*

*Élimination rénale faible (< 4%). Données limitées chez les patients avec ClCr $\leq$ 20 ml/min¹.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique¹

Médicament	Bilan hépatique	Ajustement posologique recommandé
Géfitinib	Insuffisance hépatique modérée à sévère (Child-Pugh B ou C*) associée ou non à des métastases hépatiques Augmentation des AST, de la phosphatase alcaline et/ou bilirubine associée à des métastases hépatiques	Administer 100% de la dose mais surveillance étroite

AST : aspartate aminotransférase

*Voir [annexe](#) pour score Child-Pugh

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Aucun ajustement de dose n'est recommandé pour les toxicités hématologiques ([voir section 4 - Monitoring](#)).

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4¹

Aucun ajustement de dose n'est recommandé pour les toxicités non hématologiques ([voir section 4 - Monitoring](#)). Une interruption de dose jusqu'à la résolution des symptômes ou jusqu'à 14 jours peut être nécessaire.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Des **nausées et des vomissements** peuvent rarement survenir et sont généralement de faible intensité (grade 1 ou 2). Ils sont bien maîtrisés par les antiémétiques ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))¹.

Les **éruptions cutanées** ont été l'effet indésirable le plus fréquemment rapporté¹. Elles sont généralement de grade 1 ou 2. L'éruption acnéiforme touche le visage, le cou et la partie supérieure du tronc. En général, les éruptions cutanées provoquées par les inhibiteurs de l'EGFR atteignent leur paroxysme en l'espace de 4 à 6 semaines et s'atténuent après 8 semaines de traitement. Toutefois, les altérations de la peau qui leur sont associées (plaques rouges surélevées, changement de couleur de la peau) peuvent persister pendant des mois, voire des années. Par conséquent, il est recommandé d'adopter des mesures préventives plutôt que des mesures réactives³.

- › Une prophylaxie à base de crème hydratante, d'hydrocortisone topique et d'antibiotiques oraux (minocycline ou doxycycline) peut être instaurée dès le début du traitement en même temps que les mesures non pharmacologiques ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))³.

- › Certains médicaments utilisés dans le traitement de l'acné sont à proscrire, tels que le peroxyde de benzoyle et les rétinoïdes étant donné qu'ils peuvent aggraver le rash compte tenu de leurs propriétés asséchantes et irritantes.
- › Une prise en charge de l'éruption cutanée est disponible dans le guide suivant : [On Cible 2015](#)³.

Les cas sévères peuvent nécessiter une interruption de traitement (jusqu'à 14 jours)¹.

La **diarrhée** est fréquente, généralement de grade 1 ou 2 et survient habituellement dans le premier mois de traitement. Elle ne s'aggrave pas avec la durée du traitement et répond bien au lopéramide ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). Dans certains cas, elle peut être grave (grade 3 et 4), entraîner une déshydratation et nécessiter une interruption de traitement (jusqu'à 14 jours). Quelques cas de saignements gastro-intestinaux ont été rapportés¹.

Des cas de **perforation gastro-intestinale** incluant des décès ont rarement été rapportés. La plupart des cas ont été associés à des facteurs de risque connus (histoire d'ulcère gastro-intestinal, tabagisme, utilisation concomitante d'AINS ou de stéroïdes, etc.). En présence d'un diagnostic de perforation gastro-intestinale, cesser le gécitinib définitivement¹.

Des cas de **pneumonite interstitielle** incluant des décès ont rarement été signalés. L'apparition soudaine ou l'aggravation de symptômes pulmonaires inexpliqués tels que dyspnée, toux et fièvre, commande l'interruption du traitement en attendant l'évaluation diagnostique. Si la présence de pneumonie interstitielle est confirmée, interrompre le traitement et instaurer une thérapie appropriée¹.

L'élévation des AST/ALT et de la **bilirubine** a été observée. Cette élévation est généralement transitoire et habituellement de grade 1. Il est recommandé de cesser définitivement le gécitinib en présence d'une hépatotoxicité sévère¹.

Des **problèmes oculaires** ont été rapportés, soit la conjonctivite, la blépharite et la sécheresse oculaire¹. Ceux-ci sont généralement de grade 1. La conjonctivite d'origine infectieuse peut se résorber d'elle-même après 1 semaine (virale) ou être traitée par un antibiotique topique (bactérienne). En présence de symptômes légers de sécheresse oculaire, des larmes artificielles peuvent être prescrites 4 à 6 fois par jour. En présence de symptômes graves ou en l'absence de réponse aux larmes artificielles, il est préférable de consulter un ophtalmologiste³.

Tableau des effets indésirables de l'étude de Mok⁵

Effets indésirables n = 607	Incidence globale (%)	Grade 3-5 (%)
Rash	66,2	3,1
Diarrhée	46,6	3,8
Peau sèche	23,9	0
Anorexie	21,9	1,5
Prurit	19,4	<1
Stomatite	17,0	<1
Asthénie	16,8	<1
Nausées	16,6	<1
Paronychie	13,5	<1
Vomissement	12,9	<1
Constipation	12,0	0
Alopécie	11,0	0
Effets neurotoxiques	10,9	<1

CTCAE version 3.0

4.2. Interactions cliniquement significatives^{1,6,7}

Le géfitinib est un substrat des CYP450 3A4 et 2D6 (majeur) et du 1A1 (mineur). Il inhibe les CYP450 2D6 et 2C19 (faible).

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	↑ des concentrations de géfitinib. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations de géfitinib. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Substrats du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, verapamil, ritonavir, carbamazépine, etc.)	↑ possible des concentrations de géfitinib en raison de compétition avec un autre substrat de ce cytochrome. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence.
Inhibiteurs puissants du CYP450 2D6 (p. ex. : fluoxétine, paroxétine, quinidine, etc.)	↑ des concentrations du géfitinib. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Médicaments augmentant le pH gastrique (p. ex. : antiacides, anti-H ₂ , IPP)	↓ possible de la biodisponibilité du géfitinib (altération de la solubilité). <i>Sévérité : majeure</i>	Si possible, éviter la co-administration. Sinon, privilégier anti-H ₂ . Administer le géfitinib au moins 2 heures avant et 10 heures après la prise de l'anti-H ₂ .
Warfarine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire¹

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, électrolytes, AST/ALT, bilirubine, créatinine, urée
Tous les mois	AST/ALT, bilirubine
Si cliniquement indiqué	FSC, électrolytes, créatinine, urée

5. Références

1. AstraZeneca Canada Limitée. Monographie du géfitinib (Iressa). Mississauga, Ontario. Septembre 2017.
2. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Consulté le 15 octobre 2017, disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
3. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 15 octobre 2017, disponible à l'adresse : http://www.geoq.ca/pro/doc/2015oncible_vf.pdf
4. Kiyohara Y, Yamazaki N, Kishi A. Erlotinib-related skin toxicities: Treatment strategies in patients with metastatic non-small cell lung cancer. Journal of the American Academy of Dermatology 2013 ; 69(3) : 463-72.
5. Mok TS, Wu YL, Thongprasert S, Yang CH, Chu DT, Saijo N et coll. Gefitinib or carboplatin-paclitaxel in pulmonary adenocarcinoma. N Engl J Med 2009; 361: 947-957.
6. Van Leeuwen RWF, Van Gelder T, Mathijssen RHJ et Jansman FGA. Drug-drug interactions with tyrosine-kinase inhibitors: a clinical perspective. The Lancet Oncol 2014 ; 15: e315-e326.
7. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 25 octobre 2017.

6. ANNEXE

Score de Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71 – 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 – 35	< 28
Bilirubine (µM/l)	< 35	35 – 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › Classe A = 5 à 6 points
- › Classe B = 7 à 9 points
- › Classe C = 10 à 15 points